BUSINESS PLAN ｜ 宮崎銀行様ご提出資料

事業計画書

木花のむら診療所

開院目標：2027年秋 ｜ 開設場所：宮崎市熊野・学園木花台本郷北方線沿い

地域密着型スマートクリニック構想 ― Web問診導入・電子化徹底による次世代診療所

提出日	作成者	提出先
2026年9月17日	**野村信介（開設者）**	**宮崎銀行様**

目次

1. 事業概要
2. 開業者プロフィール
3. 立地・商圏分析
4. 診療・設備計画
5. 人員計画
6. 初期投資計画
7. 資金調達計画・融資返済シミュレーション
8. 収支計画
9. リスク分析と対応策
10. 中長期計画
11. 添付予定書類

エグゼクティブサマリー

本計画の要点を以下に要約する。各数値の詳細根拠は本文の該当章（第6〜8章）を参照。

初期投資総額

268,353,000円

建物・土地・設備・開業準備費・運転資金等の合計

融資希望額（自己資金0円）

268,353,000円

初期投資総額と同額

月次返済額合計

1,422,010円

20年・金利2.5%（宮崎銀行様提出用収支計画書ベースの想定値）

損益分岐点（BEP）※院長報酬込み

47人/日（開業〜6ヶ月）／49人/日（安定期）

院長報酬（生活費相当）を織り込んだ、事業として持続可能な患者数を基準としている。院長報酬を含まない会計上の参考値は37人/日。1日目標患者数70人/日（安定期）に対し十分な余裕

月次固定費合計（院長報酬・借入元本を除く）

約415.5万円

人件費・支払利息・減価償却費等を含む（医薬品等の変動費・借入元本返済分を除く）

安定期の年間売上高（3年目〜）

10,321.4万円

3〜5年目で安定推移を見込む

1. 事業概要

項目	内容
届出名称	木花のむら診療所
診療科（標榜）	内科・消化器内科・アレルギー内科・呼吸器内科・外科・小児科
診療方針	新生児・乳児の一部診療（専門性の高い領域）は専門診療科へご紹介
開設場所	宮崎市熊野・学園木花台本郷北方線沿い（山下新橋（建設中）近辺を含む沿線上）

開業形態	土地購入＋自己建築
開院目標	2027年秋
事業主体	個人事業主（開業3〜5年後に医療法人化を視野）
診療時間	月〜金　AM 8:15〜12:15／PM 15:00〜18:30（土日祝休・開業時）。診療7.5h/日・週37.5h。将来的に土曜AM非常勤診療の段階導入を検討
1日目標患者数	70人/日（安定期目標）。損益分岐点（BEP、院長報酬込み）は開業〜6ヶ月47人/日・7ヶ月目以降49人/日（院長報酬を含まない会計上の参考値は37人/日）
規模	木造2階建・延床約333㎡（1階272㎡・2階61.5㎡）・敷地1,200〜1,500㎡・駐車場32台
ビジョン	Web問診導入・電子化徹底の地域密着型スマートクリニック

2. 開業者プロフィール

項目	内容
氏名	野村 信介（Shinsuke Nomura）
学歴	防衛医科大学校医学部卒（2008年）・同大学院博士（医学）取得（2021年）
海外研究歴	マサチューセッツ総合病院（ハーバード大学系）研究員（2018〜2019年）
専門資格	外科専門医・消化器外科専門医・健康スポーツ医・博士（医学）
主な職歴	防衛医大病院 → 災害医療センター → 自衛隊熊本病院外科部長 → 宮崎大学助教 → 県立日南病院外科医長 → 現職
現職	市内クリニック 副院長（2023年10月〜）
学術実績	査読論文65件・学術賞受賞5件以上・10学会所属・特許1件

強み	デジタル化推進・低侵襲外科・自費診療経験（AGA/ED等）・外科的処置
在宅診療	非在支診・施設定期訪問（サ高住等・月2回・最大80名・木曜午後）。24hオンコール・夜間往診は行わない
代診医	近隣在宅クリニック院長（傷病・研修・急用時の代診として事前合意予定）

3. 立地・商圏分析

立地の優位性

クリニックは、まなび野・学園台（30〜40代子育て世代の新興住宅地）から宮崎空港・宮崎港・高速IC・清武・田野方面へ向かう帰宅動線上、山下新橋（建設中）近辺の学園木花台本郷北方線沿線に位置する。橋の開通前に開院することで、開通後の交通量増加をそのまま患者増に転換できる先行者優位を確立できると考えている。

また、当院は宮崎大学・宮崎大学医学部附属病院に近接しており、宮崎大学の学生、宮崎大学および同附属病院の職員、同院の通院患者にとっても通いやすい立地にある。大学関係者という安定した通院需要層に加え、大学病院の患者にとっての身近なかかりつけ医としての受け皿にもなり得る点は、当院の優位性の一つである。

山下新橋 開通による効果

効果	内容	クリニックへの影響
計画交通量	約9,300台/日（開通後）	帰宅動線上の通過交通量増加による潜在患者層の拡大
広域アクセス向上	学園都市ハイテクパーク〜空港・港湾・ICを直結	就業者・学生層の通院利便性向上
渋滞緩和	通勤ラッシュ時の混雑分散	通勤・帰宅途中の「ついで受診」増加
防災・救急機能強化	緊急輸送道路として指定	地域の救急一次対応拠点としての位置づけ

地域活性化	宅地開発の継続	商圏人口の増加

> 計画交通量約9,300台/日は国土交通省の道路事業に基づく公表データである。

一次商圏（半径1.5km）の人口特性

エリア	人口特性
まなび野・学園台	新興住宅地・30〜40代子育て世代
木花・熊野	宮崎大学・宮崎県立看護大学の学生・教職員。宮崎大学医学部附属病院の職員・通院患者
清武・田野	既存住民・農業従事者・高齢者層
青島・内海	既存住民・観光関連従事者。エリア内の医療機関は青島リゾートクリニック1件のみと医療資源が乏しく、当院が広域からの受け皿となり得る

周辺医療機関の状況

商圏内には内科系クリニックが複数存在するが、CT撮影・外科処置・Web問診・水曜午後診療・車内待機システムを組み合わせて提供する医療機関は現時点で見当たらず、当院はこれらを差別化要素として位置づける。

4. 診療・設備計画

設備	調達方法	月額コスト
16列CT	購入（リファービッシュ優先）	保守費のみ（別途）
デジタルX線	購入（リファービッシュ優先）	保守費のみ

超音波エコー	購入（リファービッシュ優先）	保守費のみ
経鼻内視鏡システム	購入（リファービッシュ優先）	保守費のみ
FeNO（呼気NO測定）	購入	保守費のみ
電子カルテ（レセプト点検・胃カメラ連携込み）	月額契約	5万円
自動精算機	購入	初期計上（下記参照）
医療機器月額	0円（全機器購入方針のため。保守費は別途変動費として計上）	

放射線技師は採用する可能性があるが、その場合も放射線業務専任ではなく事務作業等を兼務する想定。CT撮影等は院長自身が実施可能な水準を前提とし、一次読影は院長、二次読影は外部専門医へ外注する体制とする。

自費診療

優先度	メニュー	開始時期
優先	花粉症治療（ケナコルト）・AGA・ED・にんにく注射	開業初日
A	GLP-1/マンジャロ・LOH/TRT・FAGA	開業初日
B	禁煙・点滴療法	～開業1年後

> 自費診療は融資申請上の収支計画では保守的に月30万円のみ計上している（実際の上振れ余地あり）。

5. 人員計画

区分	開業時	安定期（1～2年後）

院長（本人）	1名	1名
看護師（常勤）	2名	3名
看護師（パート）	1名	1〜2名
医療事務	2名（うち1名パート）	2名
合計	**7名**	**8〜9名**

6. 初期投資計画

> **医療機器・IT一式について（誠実な開示事項）**
> 医療機器・IT一式（4,043万円）は複数メーカーとの相見積もりが未完了の段階における保守的な想定額（ワーストケース試算）であり、確定額ではない。相見積もり完了後、価格が下振れした場合には本計画書を速やかに改訂する。

費目別内訳（確定計画値）

費目	金額	備考
建物（建設工事費）	165,000,000円	110坪×150万円/坪
土地	21,923,000円	当院取得分3筆・書面売買代金内訳に基づく確定額
土地取得費	2,000,000円	不動産取得税・登録免許税・司法書士費用・測量・境界確定
医療機器・IT一式	40,430,000円	相見積もり未完了のワーストケース試算（下記内訳参照）
開業準備費	9,000,000円	広告・採用・研修・医師会関連等
諸費用	5,000,000円	開発許可・建築確認・開設届・保険等

運転資金	25,000,000円	保険診療入金の翌々月払いと開業初期の赤字が重なる期間に備える
初期投資総額	**268,353,000円**	約2億6,835.3万円

医療機器・IT一式の内訳

項目	金額
16列CT	1,800万円
デジタルX線	350万円
超音波エコー	250万円
上部内視鏡一式	550万円
内視鏡洗浄機	200万円
FeNO測定器	60万円
心電図	100万円
電子カルテ初期費用	200万円
PACS初期費用	60.5万円
自動精算機・キャッシュレス端末	173万円
医療備品・消耗品初期在庫	300万円
合計	**4,043万円**

> 上記内訳は各品目について在庫確定前の価格ブレ・新品相場帯・資材価格上昇等を考慮した保守的な積み上げであり、本計画書における結論値とする。相見積もり完了後に確定額へ改訂する。

7. 資金調達計画・融資返済シミュレーション

融資希望額（自己資金0円・全額借入）

項目	金額
初期投資総額	268,353,000円
融資希望額（合計）	268,353,000円
月次返済額合計（20年・金利2.5%）	1,422,010円
年間返済額合計	17,064,124円
損益分岐点（BEP）	47人/日（開業〜6ヶ月）／49人/日（7ヶ月目以降・安定期）※院長報酬込み。参考：院長報酬を含まない会計上の損益分岐点は37人/日

本計画における融資希望額は**268,353,000円（約2億6,835.3万円）**である。この金額は値引き交渉を意図したものではなく、上記の確定内訳に基づく実額であることを申し添える。医療機器・IT費について相見積もりが完了し確定額が判明した場合は、速やかに本計画書を改訂する。

借入条件の分解

区分	使途	借入希望額	期間	金利	月次返済額
借入(1)　不動産系	建物・土地・土地取得費	188,923,000円	20年	2.5%	1,001,108円
借入(2)　設備・運転資金系	医療機器・IT一式・開業準備費・諸費用・運転資金	79,430,000円	20年	2.5%	420,902円
合計		**268,353,000円**			**1,422,010円**

金利2.5%・返済期間20年は、宮崎銀行様提出用収支計画書ベースの想定値である。実際の金利・融資条件は貴行との協議により最終確定する。土地は当院取得分3筆で担保設定が可能であり、担保評価額（21,923,000円以上）に加え、自己所有の個人資産による補完も可能である。

8. 収支計画

月次固定費（損益分岐点算定基礎）

費目	月額	備考
人件費（スタッフ・院長報酬除く）	190万円	正看護師2名・准看護師1名・看護師パート1名・医療事務2名（うちパート1名）の合計7名体制
電子カルテ月額	5万円	
読影外注	3万円	CT二次読影
IT・業務支援サブスク	1万円	
光熱費	8万円	CT・空調含む
保険・広告・雑費	25万円	
医師会費	約3.7万円	市郡・県・日本医師会の3会合計を月割
支払利息	約54.9万円	借入返済のうち利息分（1年目・保守的に固定して試算。元本返済分は損益計算上の費用に含めないため本表から除外）
減価償却費（月割）	約124.9万円	年間1,498.8万円（建物825.0万円＋医療機器673.8万円）を月割
地代	0円	土地購入のため不要
固定費合計（院長報酬・変動費・借入元本を除	**約415.5万円**	

く）		

上記の人件費190万円は本計画における確定値である。なお、社会保険料等の細目については社会保険労務士による最終確認を予定しており、確認結果に応じて軽微な調整を行う可能性がある。医薬品・消耗品等は患者数に連動する変動費として下表のとおり別途算定しており、上記固定費には含めていない。また、借入元本返済分（月次返済額合計142.20万円のうち利息分を除いた部分）はキャッシュフロー上の支出であるが、損益分岐点の算定上は費用計上せず、代わりに実際の費用計上項目である減価償却費を含めている。

変動費

費目	内容
医薬品・消耗品等	フルデイ1人あたり月次保険収入129,000円に対し変動費率19.1%と想定。真の限界利益は1人あたり104,361円（約10.44万円）

損益分岐点（BEP）の定義に関する開示
本計画書における損益分岐点（BEP）は、院長報酬（生活費相当）を含めて算出した「事業として持続可能な患者数」を基準としている。開業〜6ヶ月は院長報酬100万円/月、7ヶ月目以降は125万円/月を織り込んでいるため、フェーズにより基準値が異なる（開業〜6ヶ月：47人/日、7ヶ月目以降：49人/日）。参考として、院長報酬を含まない会計上の損益分岐点は37人/日である。

院長報酬計画

時期	院長報酬	月次固定費合計（院長報酬込み）	損益分岐点（BEP）
開業〜6ヶ月	100万円	約515.5万円	47人/日
7ヶ月目以降（安定期含む）	125万円	約540.5万円	49人/日

減価償却費（年間）

区分	年間償却額

建物	825.0万円
医療機器	673.8万円
合計	**1,498.8万円**

売上高・年次損益概算（1〜5年目）

年度	年間売上高	年間損益（税引前概算）
1年目	4,891.8万円	▲2,284万円
2年目	9,331.4万円	+2,032万円
3年目	10,321.4万円	+3,049万円
4年目	10,321.4万円	+3,077万円
5年目	10,321.4万円	+3,105万円

年次損益概算の前提に関する開示
上記の年次損益概算は、（1）人件費190万円/月を全期間固定として計算していること、（2）医薬品・消耗品等の変動費を固定費として簡略化して計算していることを前提としている。実際には患者数が増加する2〜3年目にかけて人件費・変動費も増加すると見込まれるため、上記は利益をやや過大に見積もっている可能性がある。この点は税理士法人との正式な収支計画表の突合を経て、面談後に精査・確定する予定である。

料金表・実施率の考え方

区分	主な内容	想定単価/回	売上への考え方
内科保険診療	生活習慣病・感染症・慢性疾患	4,000〜6,000円	再診・処方・検査で平均化

外科保険診療	創傷処置・切開・縫合・ドレッシング	5,000〜10,000円	エリア差別化の中核
画像検査	CT・X線・エコー	8,000〜20,000円	件数は少ないが単価を押し上げる
内視鏡	経鼻胃カメラ	10,000〜20,000円	開業後の需要に応じて拡大
自費診療	GLP-1/マンジャロ・AGA・ED・LOH/TRT・FAGA	5,000〜50,000円	融資申請上は月30万円で保守計上

収支計画では保険診療中心の平均単価を6,000円/人、自費診療を月30万円に抑えて保守的に計上している。

9. リスク分析と対応策

リスク	対応策
市街化調整区域・開発許可の可否	都市計画課への事前確認を最優先で実施
農地転用手続き	対象筆について農業委員会への正式照会・申請手続きを進行中
地盤改良費の超過	設計前に地盤調査を実施し、予備費で対応
患者数が想定を下回る	院長報酬を段階的に設定。損益分岐点（院長報酬込み）である47〜49人/日は達成可能な水準と考えている
医療機器の相見積もり未完了	本計画書では保守的な想定額（4,043万円）を結論値とし、確定額判明後に速やかに改訂する方針
院長の傷病・長期不在	近隣在宅クリニックの医師を代診医として事前合意を形成予定
医療機器の故障・保守条件	複数メーカーでの相見積もり・保守契約の締結

競合クリニックの新規参入	山下新橋開通前の先行開院で地域信頼を先取り
診療報酬改定による収入減	自費診療比率を徐々に高め保険依存度を下げる
金利上昇	固定金利商品の活用も含めて検討

10. 中長期計画

フェーズ	時期	KPI目標	主要アクション
立ち上げ	開業〜12ヶ月	損益分岐点（院長報酬込み、47〜49人/日）の達成・上回り	地域認知獲得・口コミ形成
成長	2〜3年目	患者数増加・売上高安定化（年間売上高約1億円水準）	自費診療拡大・胃カメラ需要獲得
安定	3年目〜	フルデイ70人・月次余剰安定	企業健診・在宅診療の本格展開
法人化	開業3〜5年後	医療法人設立	節税・事業継承・多店舗展開の検討

開業3〜5年後、年間利益の水準を踏まえ顧問税理士と法人化を検討する。

11. 添付予定書類

- 院長の履歴書・資格証明書一式
- 直近2年の確定申告書（源泉徴収票）
- 自己資金・資産残高証明書
- 既存ローン返済明細
- 土地売買契約書・登記事項証明書（確定後）

- 農地転用許可書（農業委員会）
- 建設会社の見積書（入札結果・選定業者）
- 医療機器見積書（各メーカー）
- 代診医の確認書

本計画書の数値は現時点における最終確定計画値である。ただし医療機器・IT一式（4,043万円）は相見積もり未完了のワーストケース試算であり、確定額判明後に改訂する。土地代・自動精算機費用・電子カルテ初期費用・医師会関連費用は書面・見積書に基づく確定額である。金利2.5%・融資期間20年は本計画における想定値であり、貴行との協議により最終確定する。年次損益概算は簡略化した前提（人件費固定・変動費を固定費扱い）を含むため、正式な収支計画表とは面談後に別途照合・確定する予定である。

作成日：2026年9月11日